Ospedale Maggiore della Collina
Azienda Sanitaria Zona Collinare Torinese
S.C. Anatomia Patologica - Patologia Epatica
Direttore: Dott.ssa Marta Bertolotto

Corso Casale 312
10132 Torino
Tel. 011 8193307
Fax 011 8193399

REFERTO ISTOLOGICO - BIOPSIA EPATICA

Agobiopsia epatica percutanea ecoguidata (18G) - valutazione di attività e fibrosi

ASSISTITO STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE

Cognome e nome:	**EL AMRANI YOUSSEF**	Sesso / età:	**M / 37 anni**
Nato il:	**15/01/1988**	Luogo di nascita:	**Casablanca (Marocco)**
Cittadinanza:	**marocchina**	Passaporto:	**VZ4417820**
Domicilio:	**c/o Associazione Il Ponte Onlus, Via Cigna 96, Torino**	Cod. paziente:	**PZ-0088127**

Codice STP | S | T | P | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 |

N. istologico:	H-2025-01173
Ricovero DH:	DH25/44310
Biopsia eseguita il:	22/04/2025
Pervenuto il:	22.04.2025 ore 11:50
Refertato il:	30/04/2025
Esecutore:	Dott. Fabrizio Ollino (Radiologia Interventistica)

Richiedente:	Dott.ssa Laura Gribaudo
U.O.:	SC Malattie Infettive - Ambulatorio Epatologico
In copia a:	Dott. Mauro Cravero, SerD Torino Est
Mediazione:	Samira Bennani (arabo/francese)

H25-01173-A1

NOTIZIE CLINICHE

Paziente di 37 anni, in Italia dal 2019, di fede musulmana (procedura programmata al termine del Ramadan su richiesta del pz.). In anamnesi: infezione da HIV-1 diagnosticata nel 2021, in terapia antiretrovirale con bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide 50/200/25 mg con viremia soppressa; epatite cronica HCV genotipo 3a, naïve al trattamento; pregresso uso di eroina per via endovenosa, attualmente in terapia sostitutiva con metadone (metadone 60 mg/die) presso il SerD; consumo alcolico a rischio (circa 40 g/die fino al 2024); disturbo post-traumatico da stress in carico al servizio di etnopsichiatria. FibroScan 11,8 kPa con CAP 288 dB/m: discordanza con i marcatori sierici, si richiede biopsia per stadiazione prima di avviare antivirali ad azione diretta. Il sig. El Amrani ha indicato come persona di riferimento il fratello, sig. Karim El Amrani (C.F. LMRKRM84H03Z330H, tel. +39 351 776 0419), al quale **non** autorizza la comunicazione dello stato sierologico HIV.

Esami ematochimici di accompagnamento (prelievo del 14.04.25, Laboratorio Analisi del P.O.)

Parametro	Valore	Unità	Intervallo di riferimento
AST	96	U/L	10 - 40
ALT	131	U/L	10 - 50
Gamma-GT	174	U/L	8 - 61
Piastrine	118	10^3/µL	150 - 400
HCV-RNA	2.340.000	UI/mL	non rilevabile
HIV-1 RNA	< 20 copie	copie/mL	-
Linfociti T CD4+	512	cell/µL	500 - 1500
INR	1,12	-	0,80 - 1,20

MATERIALE E DESCRIZIONE MACROSCOPICA

A) Fegato, lobo destro (VIII segmento), due passaggi: due frustoli cilindrici di colorito brunastro, di cm 1,9 e 1,4 (lunghezza complessiva cm 3,3), integri, inclusi in toto in un'unica inclusione (A1). Sezioni seriate per: ematossilina-eosina, tricromica di Masson, reticolo sec. Gomori, Perls, PAS e PAS-diastasi. Campionamento a cura della TSLB Erika Bussone.

DESCRIZIONE MICROSCOPICA

Campione adeguato: 14 spazi portali completi. Gli spazi portali sono ampliati da infiltrato infiammatorio linfocitario denso, con formazione di aggregati e un follicolo linfoide; epatite d'interfaccia di grado moderato in oltre il 50% degli spazi portali. Nel lobulo necrosi focali (2-4 foci per campo 10x) e corpi acidofili sparsi; cellule di Kupffer iperplastiche. Steatosi macrovescicolare in circa il 25% degli epatociti, a distribuzione panlobulare, coerente con l'effetto steatogeno del genotipo 3. Non corpi di Mallory-Denk né rigonfiamento a pallone degli epatociti; non evidenti lesioni di steatoepatite. Alla tricromica di Masson espansione fibrosa della maggior parte degli spazi portali con frequenti setti porto-portali (bridging), senza noduli completi. Depositi di emosiderina di grado 1 alla colorazione di Perls, prevalentemente nelle cellule di Kupffer. Dotti biliari conservati, senza duttopenia. Non displasia epatocitaria.

Punteggi semiquantitativi

Sistema	Parametro	Punteggio	Nota
Ishak (mHAI)	Attività necroinfiammatoria (grading)	9/18	A: 3, B: 0, C: 2, D: 4
Ishak	Fibrosi (staging)	4/6	Bridging porto-portale e porto-centrale frequente
METAVIR	Attività / Fibrosi	A2 / F3	Correlazione con elastografia
Brunt (NAS)	Steatosi / ballooning / flogosi lobulare	1 / 0 / 1	NAS non applicabile in epatite virale

INDAGINI ISTOCHIMICHE E IMMUNOISTOCHIMICHE

Indagine	Esito	Commento
Tricromica di Masson	fibrosi a ponte	Setti porto-portali e porto-centrali, architettura conservata
Reticolo (Gomori)	trabecole regolari	Assenza di ispessimento trabecolare e di noduli rigenerativi
Perls	siderosi grado 1	Prevalente nelle cellule di Kupffer, non epatocitaria
PAS / PAS-diastasi	negativo per globuli	Esclusi globuli di alfa-1-antitripsina
HBsAg / HBcAg	negativi	Assenza di coinfezione HBV tissutale
CK7 / CK19	dotti conservati	Lieve reazione duttulare periportale, non metaplasia biliare
CD3 / CD20	infiltrato misto T e B	Aggregati linfoidi portali tipici dell'epatite C
p62 / ubiquitina	negativi	Non inclusioni citoplasmatiche (esclusi corpi di Mallory-Denk)

CORRELAZIONE CLINICO-PATOLOGICA

Il dato istologico (stadio Ishak 4) è sostanzialmente concordante con l'elastografia (11,8 kPa) e con un indice APRI di 2,03, mentre il FIB-4 (3,41) tendeva a sovrastimare. La steatosi è più verosimilmente virus-indotta (genotipo 3a) che metabolica: BMI riferito 22,4 kg/m², assenza di diabete. L'ART in corso non contiene farmaci con nota epatotossicità steatogena rilevante. Sulla base di questi elementi, la Dott.ssa Gribaudo ha programmato l'avvio di sofosbuvir/velpatasvir 400/100 mg per 12 settimane, previa verifica delle interazioni con la terapia antiretrovirale e con il metadone, in accordo con il Dott. Cravero del SerD.

DIAGNOSI

Agobiopsia epatica: epatite cronica HCV-correlata con attività necroinfiammatoria moderata (Ishak grading 9/18) e fibrosi a ponte, stadio Ishak 4 (METAVIR F3); steatosi macrovescicolare del 25%; siderosi di grado 1. Assenza di cirrosi e di lesioni nodulari displastiche nel materiale esaminato.

> *Commento: in un paziente con coinfezione HIV/HCV e consumo alcolico pregresso, il quadro istologico non mostra componente di steatoepatite alcolica. Lo stadio di fibrosi avanzata giustifica l'avvio prioritario della terapia con antivirali ad azione diretta e l'inserimento nel programma di sorveglianza ecografica semestrale. Il caso è stato rivisto con il Dott. Pier Carlo Ghiglione (seconda opinione, 29 aprile 2025).*

(1) Il sistema di Ishak (1995) e il METAVIR (1996) sono riportati per confronto con le casistiche di letteratura; il punteggio di Brunt è citato solo per escludere una componente metabolica.
(2) Su richiesta del pz., il colloquio di restituzione dell'esito si terrà in presenza della mediatrice S. Bennani e senza familiari; appuntamento fissato per il 06/05/2025 presso l'Ambulatorio Epatologico.
(3) Vetrini A1/HE e A1/Masson disponibili per revisione presso l'archivio, rif. H25-01173-A1.

REGISTRO DELLA CATENA DI CUSTODIA DEL CAMPIONE

Fase	Data e ora	Operatore	Note
Prelievo	22/04/2025 10:35	Dott. Fabrizio Ollino inf. Davide Rostagno	Due passaggi, nessuna complicanza; osservazione per 6 ore
Trasporto	22/04/2025 11:40	OSS Gianni Bosio	Contenitore in formalina 10%
Accettazione	22.04.2025 11:50	TSLB Erika Bussone	Etichette concordanti con richiesta STP
Refertazione	30/04/2025	Dott.ssa Marta Bertolotto Dott. Pier Carlo Ghiglione	Doppia lettura

Torino, 30/04/2025

Il Dirigente Medico
Dott.ssa Marta Bertolotto
Patologia epatica

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

S.C. ANATOMIA PATOLOGICA
OSP. MAGGIORE DELLA COLLINA
Dott. P.C. GHIGLIONE
Ordine Medici TO n. 21877

Promemoria per il reparto: il pz. Youssef (sig. Y. El Amrani) non dispone di tessera sanitaria; le prestazioni sono erogate in regime STP con codice valido fino al 14/10/2025. Per comunicazioni: mediatrice Samira Bennani, mediazione.collina@ospcollina.example.it.

ALLEGATO - Consenso informato alla biopsia epatica

Copia per l'archivio di Anatomia Patologica (modulo MOD-AP-17, rev. 4)

Io sottoscritto Youssef El Amrani, nato il 15/01/1988 a Casablanca, documento VZ4417820 rilasciato da Royaume du Maroc - Direction Générale de la Sûreté Nationale, assistito dalla mediatrice linguistico-culturale Samira Bennani, dichiaro di aver ricevuto dal Dott. F. Ollino informazioni comprensibili, in lingua araba, sulla procedura, sui rischi (sanguinamento, dolore, pneumotorace) e sulle alternative (elastografia, marcatori sierici).

☒ Acconsento all'esecuzione dell'agobiopsia epatica percutanea ecoguidata

☒ Acconsento alla conservazione del materiale residuo per eventuali indagini diagnostiche future

☐ Acconsento all'uso del materiale residuo, in forma anonima, per ricerca scientifica

☐ Autorizzo la comunicazione dell'esito al fratello Karim El Amrani

Il paziente chiede che il proprio stato sierologico non sia riportato in documenti destinati a terzi e che eventuali comunicazioni al domicilio presso l'Associazione Il Ponte Onlus avvengano in busta chiusa intestata a "Y. E. A.".

Firma del paziente

Torino, 22.04.25 — **Youssef El Amrani**

Mediatrice

Presente al colloquio — **Samira Bennani**

Il medico che acquisisce il consenso

Dott. Fabrizio Ollino

Ore 09:10